Chapitre 4
La santé

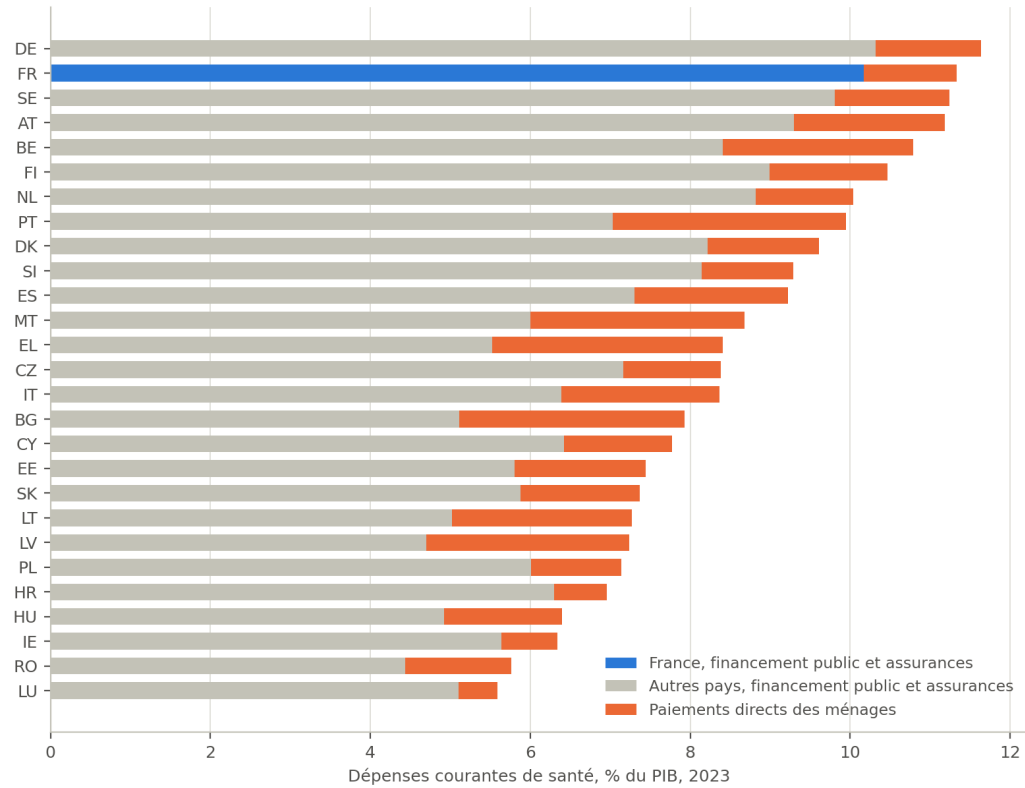
F. Candau (UPPA-TREE)

Des dépenses qui croissent plus vite que le PIB

- Depuis l'après-guerre, les dépenses de santé ont crû dans tous les pays développés plus vite que le PIB.
- La consommation de soins et de biens médicaux regroupe les soins hospitaliers, les soins de ville, les transports sanitaires, les médicaments et les autres biens médicaux (255 milliards d'euros).
- Elle se répartit entre l'hôpital **47 %**, les soins de ville **31 %** et les biens médicaux **22 %**.
- La dépense courante de santé y ajoute les soins de longue durée, les indemnités journalières, la prévention, la recherche et l'administration (333 milliards d'euros, **11,3 % du PIB**).

La dépense de santé dans l'Union européenne

La France dépense 11,3 % du PIB contre 9,9 % pour l'Union, avec un reste à charge des ménages parmi les plus faibles, environ 10 % de la dépense.



Les défaillances du marché de la santé

- Le secteur relève d'une économie de services, où les gains de productivité sont faibles et les coûts élevés.
- L'incertitude sur l'état de santé, l'asymétrie d'information entre le patient et le médecin et les monopoles créés par les brevets empêchent le marché de fonctionner seul et appellent l'intervention de l'État.
- Le chapitre examine les défaillances qui ont rendu l'assurance maladie obligatoire et la façon dont la France l'a organisée, la dynamique des dépenses et trois mécanismes de leur hausse, enfin la régulation de l'offre de soins.

Section 1

L'assurance maladie obligatoire

La sélection adverse

Deux défaillances du marché de l'assurance expliquent que la couverture maladie soit partout obligatoire.

- La première est la sélection adverse, l'assureur ne connaissant pas le risque de chaque candidat aussi bien que le candidat lui-même, asymétrie qui suffit à faire dysfonctionner le marché (Akerlof, 1970).
- Une prime calculée sur le risque moyen attire d'abord ceux qui se savent les plus exposés, ce qui élève le coût moyen des assurés, donc la prime, ce qui fait sortir les moins exposés, jusqu'à ce que le marché se réduise à un noyau de hauts risques ou disparaisse.
- Le mécanisme peut aller jusqu'à empêcher tout équilibre sur un marché concurrentiel, et lorsqu'un équilibre existe les bas risques y sont sous-assurés (Rothschild et Stiglitz, 1976).

La sélection adverse, un exemple

- À l'université Harvard, les salariés choisissaient entre plusieurs contrats d'assurance maladie, dont un plus généreux, qui remboursait mieux et attirait donc surtout ceux qui se soignaient beaucoup (Cutler et Reber, 1998).
- L'université a cessé en 1995 de prendre en charge la même proportion du prix pour tous les contrats, laissant le salarié payer la totalité de l'écart de prix.
- Les jeunes en bonne santé ont quitté le contrat le plus généreux, leur départ a élevé son coût moyen donc sa prime, ce qui a fait partir les suivants, et le contrat a été supprimé en 1997.
- L'obligation imposée à l'ensemble du groupe produit un gain d'efficience, en faisant payer aux bas risques une prime supérieure à leur risque propre, ce qui finance la couverture des hauts risques et rétablit des échanges que la sélection empêchait.

Le risque de reclassement

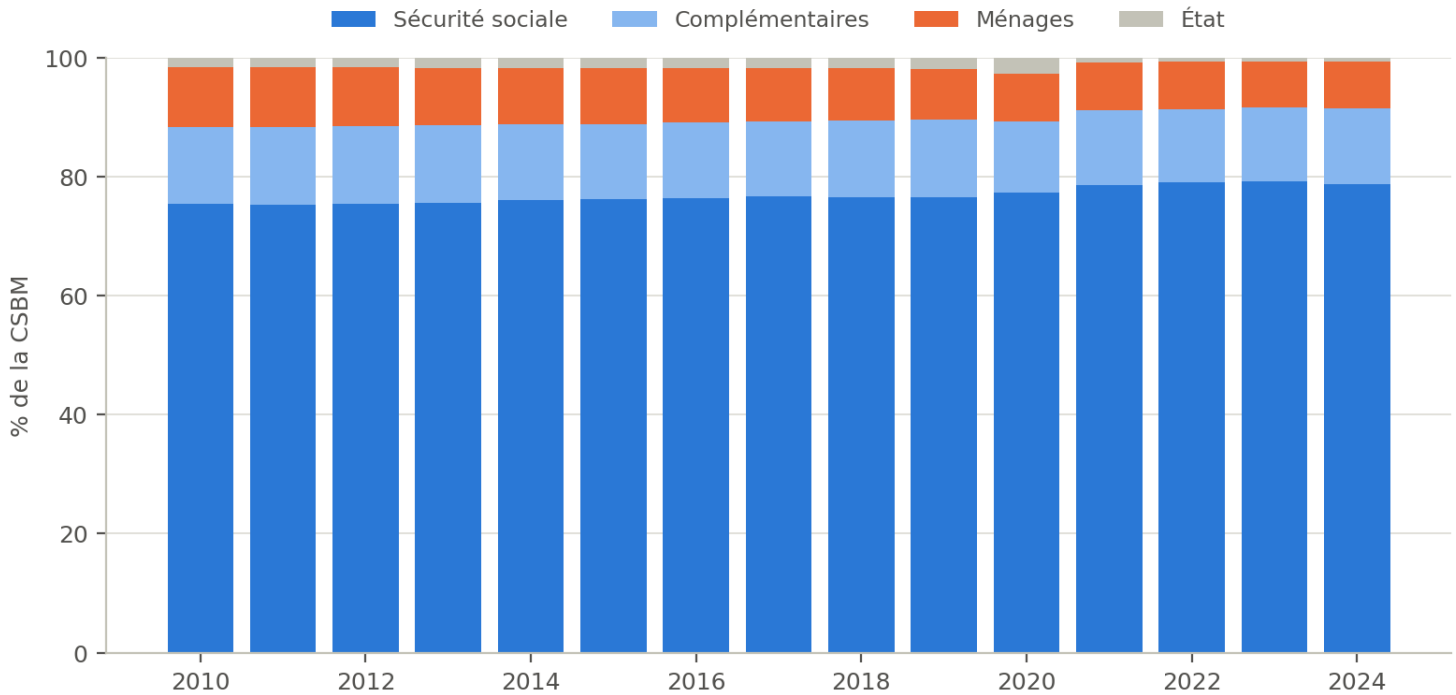
- Le risque de reclassement est celui de voir sa prime augmenter, ou son contrat refusé, parce qu'on est devenu malade.
- Un contrat privé dure un an et couvre les soins de l'année, si bien que la personne chez qui une maladie chronique se déclare voit sa prime relevée au renouvellement, au moment précis où elle a le plus besoin d'être couverte.
- Les assureurs refusent d'emblée certains antécédents au lieu de facturer une prime plus élevée, parce que la gravité réelle varie trop à l'intérieur du groupe et qu'aucune prime ne convient à la fois aux plus atteints et aux autres (Hendren, 2013).
- L'assurance sociale obligatoire couvre chacun sa vie durant à un prix indépendant de son risque, et elle est le contrat de long terme que le marché ne parvient pas à écrire.

La Sécurité sociale

La France a répondu à ces deux défaillances par une couverture publique obligatoire, doublée d'une couverture complémentaire privée.

- L'assurance maladie de base est publique et obligatoire, et depuis la protection universelle maladie de 2016 toute personne qui travaille ou réside régulièrement en France y est affiliée de droit.
- Elle rembourse les frais de soins, qui forment l'essentiel de ses prestations, et verse des indemnités journalières qui remplacent la moitié du salaire journalier de base, souvent portées à 90 % par l'employeur (Barbier, Théret et Zemmour, 2021).
- Elle prend en charge **79 %** de la CSBM, les complémentaires 13 % et les ménages 7,8 %, ce reste à charge étant l'un des plus faibles au monde.

Financement de la CSBM par type de financeur



Les complémentaires devenues obligatoires

- La couverture complémentaire, historiquement mutualiste et facultative, est devenue obligatoire et financée pour moitié par l'employeur pour les salariés du privé (accord national interprofessionnel de 2013, applicable en 2016), puis pour les agents de l'État (2025).
- Ceux qui n'ont pas d'employeur, retraités, chômeurs et indépendants, ont eux aussi une complémentaire, mais ils la souscrivent seuls et en paient la totalité, à des tarifs libres qui augmentent avec l'âge (DREES, 2024b).

Le coût du double dispositif

- Chaque remboursement est traité deux fois, par la caisse puis par la complémentaire, et les complémentaires consacrent 19,3 % de leurs cotisations à leurs charges de gestion (DREES, 2024a).
- Le premier poste en est l'acquisition de clientèle, publicité et rémunération d'intermédiaires, dépenses sans objet pour un assureur public en monopole.
- Les exonérations sociales et fiscales qui soutiennent les contrats collectifs pèsent sur les recettes de la Sécurité sociale (Zemmour, 2015).
- L'assurance complémentaire reconstitue ainsi la sélection par l'âge et les frais commerciaux que l'assurance sociale avait été inventée pour éviter.

Section 2

La dynamique des dépenses

La croissance des dépenses depuis 1950

Les dépenses de santé françaises ont crû en deux temps depuis 1950, avant de ralentir sous l'effet des politiques de maîtrise.

- De 1950 à 1985 la croissance est très forte, de l'ordre de 7 % par an en volume, puis elle ralentit jusqu'à environ 2 % par an à la veille de la crise sanitaire.
- L'essor d'après-guerre tient à la croissance des revenus, la santé étant un bien supérieur, et à l'extension de l'assurance maladie des salariés à l'ensemble des résidents, qui a levé la contrainte de prix.
- Côté offre, un vaste programme de construction d'hôpitaux a doté le territoire d'établissements modernes, et la densité médicale a triplé entre 1950 et 1980.

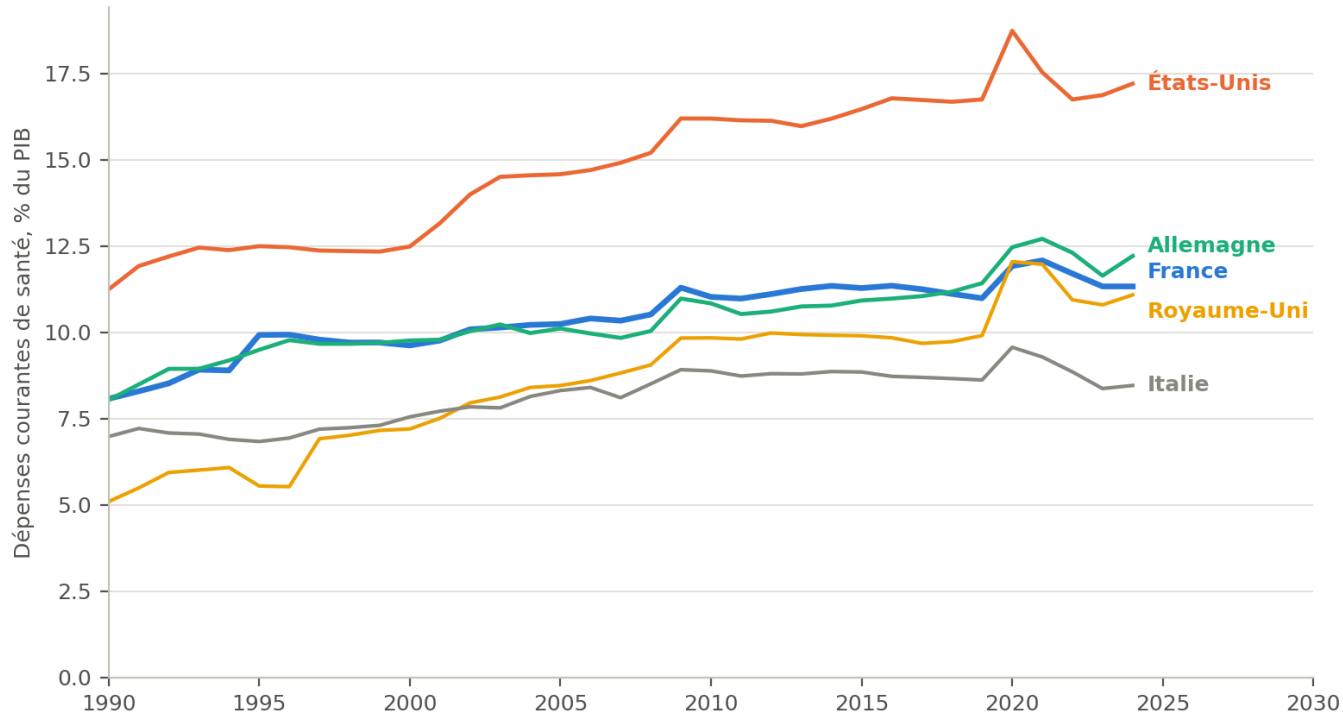
La crise des comptes et les réformes de maîtrise

Le système entre en crise dans les années 1980 et 1990, et les gouvernements successifs mènent plusieurs réformes pour contenir les déficits.

- Les comptes de l'assurance maladie deviennent durablement déficitaires, le déficit de la branche atteignant une dizaine de milliards d'euros au début des années 2000.
- La réforme de 1996 crée les lois de financement de la sécurité sociale, votées chaque année par le Parlement, et un objectif national de dépenses d'assurance maladie ; celle de 2004 organise le parcours de soins autour du médecin traitant et instaure la participation forfaitaire, complétée par les franchises en 2008.
- Le déficit revient de 11,4 milliards d'euros en 2011 à 1,9 milliard en 2019, la croissance des dépenses étant ramenée à **2,3 %** par an contre plus de 4 % auparavant, avant de remonter à 13,8 milliards en 2024.

Dépenses courantes de santé en % du PIB

La France n'a pas été plus dépensière que les pays comparables, avec 11,3 % du PIB en 2024 contre 12,2 % en Allemagne et 17,2 % aux États-Unis.



Les déterminants de la hausse

Cinq facteurs sont invoqués, le revenu, l'extension de la couverture, le vieillissement, le progrès technique et le coût relatif des soins.

- Le vieillissement proprement dit, la déformation de la structure par âge, explique **3 %** de la hausse française entre 1992 et 2000 (Dormont, 2009).
- Le changement des pratiques médicales à âge et à état de santé donnés en explique **58 %** : on traite le même patient autrement qu'il y a vingt ans.
- Le même résultat vaut aux États-Unis (Newhouse, 1992), et les technologies dont le bénéfice est faible mais le coût élevé expliquent une part importante de la hausse (Chandra et Skinner, 2012).
- La question est donc le rendement marginal de la dépense, le gain de santé qu'apporte un euro de plus consacré aux soins.

La maladie des coûts

Au-delà du vieillissement et du prix des innovations, trois mécanismes propres au secteur expliquent la hausse des dépenses, et le premier porte sur le prix des soins plutôt que sur leur volume.

- Les salaires d'un secteur suivent ceux du reste de l'économie même lorsque sa productivité y stagne, si bien que ses coûts unitaires augmentent tendanciellement (Baumol, 1967).
- Dans les métiers du soin, où l'on s'occupe de personnes et non de biens produits à la chaîne, il est difficile de produire davantage à service égal, la chirurgie et l'imagerie faisant exception (Baumol, 2012).
- Ces métiers doivent pourtant offrir des salaires comparables à ceux des secteurs où la productivité augmente, sans quoi ils ne recrutent plus.

La demande induite

Le deuxième mécanisme tient au comportement des offreurs de soins, et porte cette fois sur le volume.

- La seule demande propre du patient est la consultation, tout le reste, examens, actes, médicaments, équipements et hospitalisations, étant prescrit ou conseillé par le professionnel qu'il consulte.
- L'offreur transforme la demande primaire du patient en demande finale, ce qui fait dépendre la consommation de soins de l'offre elle-même.
- Le patient n'a l'expertise nécessaire ni pour formuler une demande précise ni pour évaluer le service rendu, et celui qui détient l'information peut en user à son profit (Arrow, 1963).

La demande induite, un exemple américain

La demande induite est difficile à établir, parce qu'un médecin qui réalise beaucoup d'actes peut simplement soigner des patients qui en ont besoin. Il faut une situation où son activité varie pour une raison étrangère à l'état de santé de sa patientèle.

- La natalité américaine chute dans les années 1970, si bien que l'obstétricien qui exerce là où les naissances reculent réalise moins d'accouchements, donc perçoit un revenu plus faible, sans que la santé de ses patientes ait changé (Gruber et Owings, 1996).
- La césarienne est mieux rémunérée que l'accouchement par voie basse et son indication relève du jugement du médecin, si bien que le taux de césariennes doit s'élever là où les naissances baissent, si la demande induite existe.
- C'est ce que les auteurs trouvent, de 0,6 point pour 10 % de naissances en moins, effet modeste mais robuste.

La demande induite, deux autres résultats

- La probabilité de césarienne est inférieure d'environ 10 % lorsque la patiente est elle-même médecin, ce qui rattache l'écart à l'asymétrie d'information (Johnson et Rehavi, 2016).
- Une hausse de 2 % du tarif d'un acte accroît son volume d'environ 3 %, surtout pour les actes programmés, dont la date et l'opportunité dépendent du médecin (Clemens et Gottlieb, 2014).
- Ces travaux n'établissent pas que les médecins agissent contre l'intérêt de leurs patients, mais que dans la zone d'incertitude médicale, où plusieurs conduites se défendent, la rémunération pèse sur le choix.

L'aléa moral

Le troisième mécanisme tient au comportement des patients, dont la consommation n'est plus freinée par le prix une fois qu'ils sont couverts.

- Les patients ne paient qu'une faible part de ce qu'ils consomment et auraient tendance à sur-consommer, ce que l'on nomme aléa moral.
- Pour faire internaliser au consommateur le prix réel des soins, on lui en fait payer une partie, par le ticket modérateur, pourcentage du tarif laissé à sa charge, et par des participations forfaitaires, sommes fixes par consultation ou par boîte de médicament.
- Les contrats privés américains vont beaucoup plus loin. Ils comportent une franchise, montant de dépenses annuelles que l'assuré règle lui-même avant que l'assurance ne commence à rembourser.

L'aléa moral, un exemple

- **L'expérience du RAND**, menée aux États-Unis de 1974 à 1982, a réparti au hasard des familles entre des contrats plus ou moins couvrants.
- Selon Manning et al. (1987), une couverture intégrale accroît la consommation de soins d'environ 45 % par rapport à un contrat laissant 95 % de la dépense au patient, sans effet mesurable sur l'état de santé sauf pour les plus pauvres et les plus malades.
- Cette ampleur n'est plus considérée comme crédible, la participation à l'expérience n'ayant pas été la même selon le contrat tiré au sort (Aron-Dine, Einav et Finkelstein, 2013).
- En corrigeant cette sélection, l'écart de dépense entre les deux contrats se réduit fortement et la réponse des dépenses hospitalières ne se distingue plus de zéro.

L'aléa moral, un exemple dans les pays en développement

- Faute d'information sur la qualité, le patient peut prendre le prix pour un signal de qualité, ce qui a conduit certains acteurs du développement à préconiser de faire payer les traitements.
- Des moustiquaires distribuées gratuitement ou à prix réduit à des femmes enceintes montrent que la demande s'effondre dès que le prix devient positif, sans que ceux qui ont payé les utilisent davantage (Cohen et Dupas, 2010).
- La loi de la demande est vérifiée, et un retrait de la couverture réduit la consommation de soins, y compris de soins utiles, et creuse les inégalités d'accès.

Le reste à charge et les complémentaires

- Le ticket modérateur, part du tarif laissée à l'assuré, est remboursé par sa complémentaire, et les sommes qui restent à sa charge sont plafonnées à cinquante euros par an.
- L'assuré ne rencontre donc guère le prix du soin au moment où il le consomme, ce qui a pu entretenir un niveau de consommation élevé.
- La responsabilisation emprunte un autre canal, les charges transférées vers les complémentaires se retrouvant dans les cotisations, qui ont augmenté de 8,2 % en 2024 (DREES, 2025b).
- Le prix auquel le ménage réagit est celui de la couverture et il ne dépend pas du revenu, la cotisation représentant 6 % du revenu des retraités les plus modestes et 2 % de celui des plus aisés (DREES, 2025c).

Section 3

La régulation de l'offre de soins

Hôpital

Le financement de l'hôpital

Face à la hausse des dépenses, ou pour moderniser son système de santé, la France a entamé différentes réformes de l'hôpital, des soins de ville et du secteur pharmaceutique.

- La dotation globale, instaurée en 1983, alloue à chaque établissement une enveloppe annuelle fixe.
- Elle plafonne ainsi le budget de chaque établissement, mais elle fige les inégalités entre eux et ne finance pas l'activité supplémentaire.

La tarification à l'activité

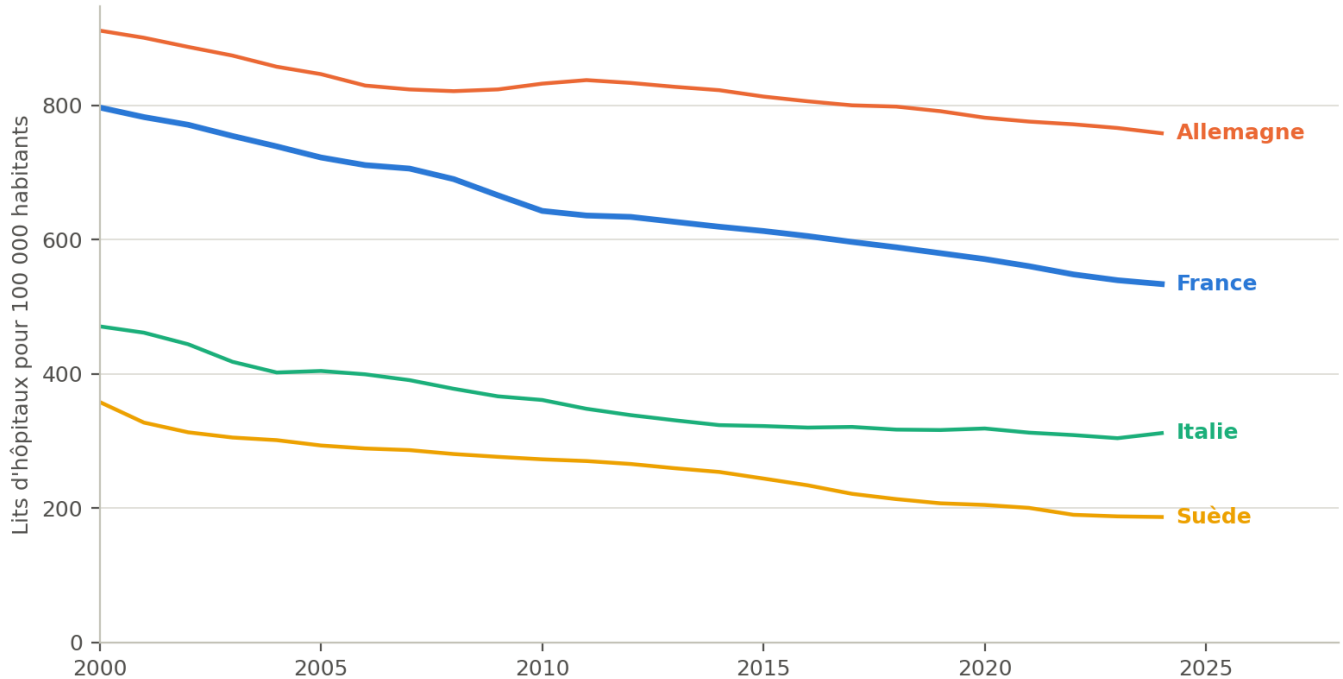
- La tarification à l'activité, généralisée en 2008 pour la médecine, la chirurgie et l'obstétrique, rémunère chaque séjour à un tarif forfaitaire fixé selon la pathologie.
- Elle suit l'activité réelle des établissements et permet leur comparaison, chaque surcoût étant un signal d'inefficacité.
- Cette tarification conduit l'hôpital à réduire le coût de chaque séjour et à en réaliser davantage, ce qui pousse à standardiser les prises en charge et à privilégier les séjours les mieux tarifés, au risque d'un codage avantageux (Milcent, 2021).
- Les réformes récentes tendent vers un financement combiné, où le forfait n'est plus qu'une part du budget des hôpitaux (Cour des comptes, 2023).

Le virage ambulatoire

- La chirurgie ambulatoire est passée de 38 % des interventions en 2008 à 64 % en 2023.
- Les raisons en sont d'abord budgétaires, l'hospitalisation complète étant le mode de prise en charge le plus coûteux, et tiennent aussi aux innovations médicales, anesthésie locale et chirurgie peu invasive.
- Les soins de ville sont désormais le principal contributeur à la croissance des dépenses, mais la structure des dépenses entre hôpital et ville a peu évolué dans ses grands agrégats.

Lits d'hôpitaux pour 100 000 habitants

La France comptait 797 lits pour 100 000 habitants en 2000 et 534 en 2024, soit une baisse d'un tiers.



Médecine de ville

La rémunération du médecin de ville

- La médecine de ville est payée à l'acte, si bien que le revenu du médecin dépend du nombre d'actes qu'il réalise.
- Le médecin traitant reçoit en outre un forfait annuel par patient inscrit, qu'il l'ait vu ou non, de 5 euros pour un adulte sans pathologie chronique à 70 euros pour un patient de plus de 80 ans en affection de longue durée. Ce paiement par tête s'appelle la capitation.
- Une rémunération sur objectifs de santé publique paie des résultats mesurés sur une trentaine d'indicateurs, pour 5 361 euros en moyenne par généraliste en 2024.
- La capitation a le défaut inverse du paiement à l'acte, elle paie aussi l'inaction.
- La réforme de 2026 fusionne le forfait patientèle et la rémunération sur objectifs en un forfait unique, dont une part varie selon les vaccinations, dépistages et consultations effectivement réalisés.

Secteurs et dépassements d'honoraires

- La convention de 1980 a créé deux secteurs, le secteur 1 où le médecin s'engage à respecter le tarif, le secteur 2 où il fixe librement ses honoraires.
- Le dépassement reste à la charge du patient ou de sa complémentaire, il est rare chez les généralistes et fréquent chez les spécialistes, concentré dans certaines disciplines et dans les grandes villes.
- Les conventions successives ont restreint l'accès au secteur 2, puis proposé depuis 2016 un contrat qui plafonne les dépassements en échange d'avantages tarifaires et sociaux.

Le numerus clausus et la répartition

- Instauré en 1971, il fixait chaque année le nombre d'étudiants admis, sans empêcher le nombre de médecins de passer de 59 000 en 1968 à 209 000 en 2009.
- Restreindre le nombre de médecins ne restreint pas leur activité, ceux qui sont en place pouvant accroître le nombre d'actes.
- Fixé par région, il n'a pas réparti les soignants sur le territoire, la densité d'omnipraticiens en Seine-Saint-Denis étant deux fois plus faible que dans les Pyrénées-Orientales.
- Il a été supprimé par la loi de 2019, mais l'installation reste libre et la densité, 346 médecins pour 100 000 habitants, demeure très inégale d'un département à l'autre.

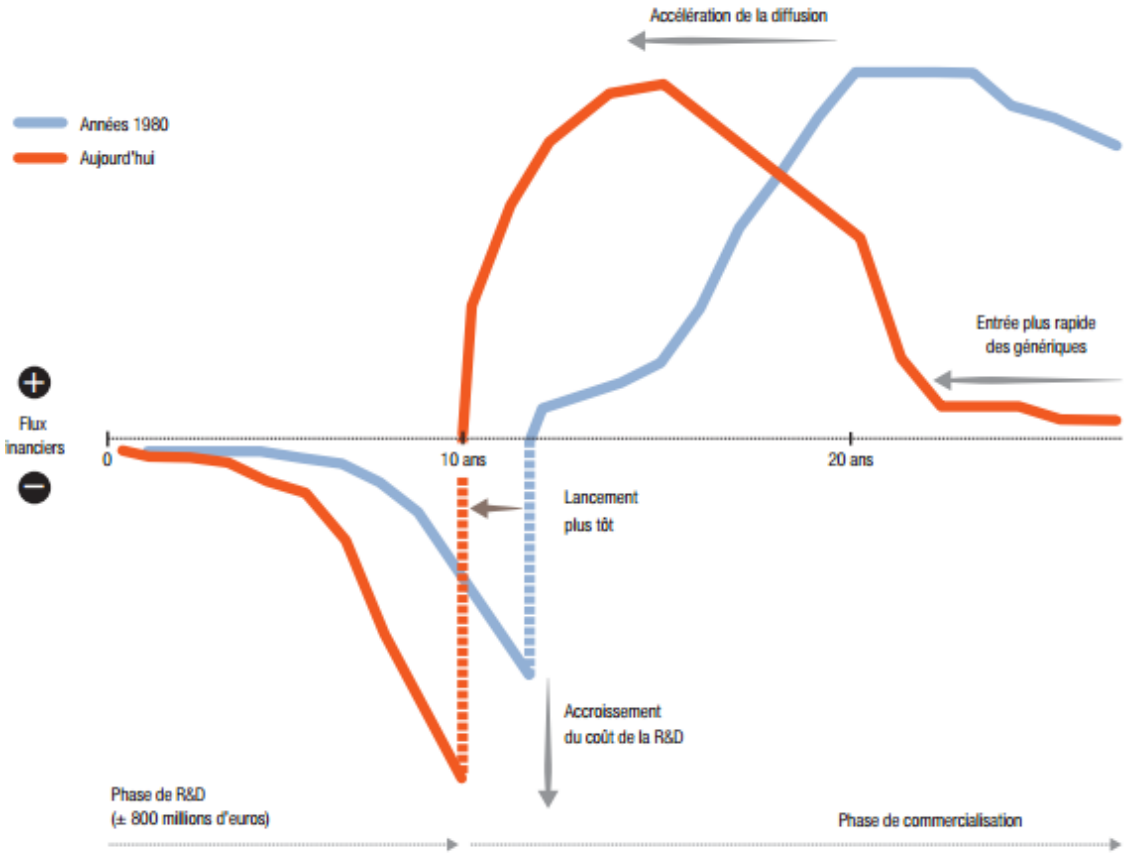
Secteur pharmaceutique

Le brevet, le prix et l'innovation

- Le brevet place son titulaire en monopole, qui fixe un prix supérieur au coût marginal et prive de traitement les patients prêts à payer ce coût mais pas ce prix.
- Deux éléments limitent ce pouvoir, l'expiration du brevet, qui ouvre la voie aux génériques, et l'existence de molécules concurrentes ; les laboratoires se sont tournés vers des médicaments de niche vendus très cher (Lakdawalla, 2018).
- Réduire la durée des brevets ferait baisser les prix, mais la rente qu'ils procurent finance la recherche, dont elle est le moteur dans les modèles de croissance par l'innovation (Romer, 1990 ; Aghion et Howitt, 1992).

Le cycle de vie d'un médicament

La période de profit s'est raccourcie, la R&D coûtant plus cher et les génériques entrant plus tôt.



Le prix d'une année de vie gagnée

- Les anticancéreux inscrits avant 2000 coûtaient moins de 50 000 euros par année de vie gagnée. Les prix les plus élevés des inscriptions récentes dépassent 400 000 euros (Cour des comptes, 2017).
- Cette hausse peut venir de rendements décroissants de la recherche, les gains thérapeutiques supplémentaires étant plus difficiles à obtenir.
- Elle peut aussi venir de la stratégie d'un monopole qui fixe son prix au maximum de ce que l'acheteur public accepte de payer.
- La Cour des comptes (2017) en tire une question de soutenabilité pour le remboursement solidaire de ces traitements.

Section 4

Conclusion

Conclusion

- L'assurance maladie est sociale parce que le marché privé ne retient pas les bas risques et ne garantit pas les primes sur la durée.
- La France a poussé la couverture plus loin que la plupart des pays, au prix d'une assurance complémentaire qui reconstitue une partie des défauts que l'assurance sociale devait éviter.
- La croissance des dépenses tient au progrès médical d'abord, à la hausse du coût relatif des soins ensuite, au vieillissement pour une part plus faible qu'on ne le croit.
- Faire payer le patient se heurte à ce que la couverture doit précisément garantir, l'accès aux soins de ceux qui ont peu de moyens.

Les ordres de grandeur à retenir

- Dépense courante de santé 11,3 % du PIB, consommation de soins et de biens médicaux 255 milliards d'euros.
- CSBM, hôpital 47 %, soins de ville 31 %, biens médicaux 22 %.
- Financement, Sécurité sociale 79 %, complémentaires 13 %, ménages 7,8 %.

Section 5

Vérification des connaissances

Questions de cours

1. Pourquoi le marché privé n'assure-t-il pas correctement le risque santé ? Quelles sont les deux défaillances en cause ?
2. Qu'est-ce que la spirale de défection ? Donnez un exemple.
3. Comment se partage la prise en charge des soins entre Sécurité sociale, complémentaires et ménages ?
4. Qu'appelle-t-on maladie des coûts ? Pourquoi s'applique-t-elle particulièrement à la santé ?

Questions de cours (suite)

5. Qu'est-ce que la demande induite ? Donnez des exemples empiriques de cette demande induite.
6. Comment le mode de paiement des hôpitaux a-t-il évolué ?
7. Quels instruments encadrent la médecine de ville ? Quelles en sont les limites ?

Questions de réflexion

1. Faut-il faire payer davantage le patient pour contenir les dépenses de santé ?
2. L'État aide-t-il trop les géants de l'industrie pharmaceutique ?